Maroua, Extrême-Nord

L'essentiel des décès dus à la chaleur prévus dans l'Extrême-Nord est encore à venir, dont 910 pour le seul mois de mars. Les sels de réhydratation doivent donc être dans les quartiers, et un voisin désigné doit passer voir les personnes isolées, avant le pic de la saison chaude.

RÉGION	DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES DUS À LA CHALEUR	PÉRIODE	ALÉA PRINCIPAL
Région de l'Extrême-Nord (GADM CMR.4_1), échelle régionale	2 500 prévus d'oct. 2026 à mars 2027 (octobre 590, novembre 510, mars 910) ; 490 déjà survenus (juin–sept.)	Prévision sur 6 mois, octobre 2026 – mars 2027	Chaleur (oct.–nov. et mars–mai) ; méningite de décembre à juin ; choléra avec les pluies ; coupures d'électricité et d'eau ; soudure 2027

22 recommandations vérifiées sur 22. 3 confirmées, 19 corrigées, 0 non vérifiée, 0 contre-indiquée parmi les recommandations retenues, soit les 9 actions classées (toutes corrigées), les 4 fiches « À ne pas faire » (1 confirmée, 3 corrigées) et les 9 étapes « Pour vous » (2 confirmées, 7 corrigées). Un conseil rédigé par le panel, mouiller la peau et s'asseoir devant un ventilateur, s'est révélé nocif au-dessus d'environ 38 °C par chaleur sèche. Il constitue désormais la première fiche « À ne pas faire ». Donnée d'exposition : El Niño Heat Mortality Tracker du Climate Impact Lab, version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs, publiée pour la région de l'Extrême-Nord et non pour la ville,

SYNTHÈSE — EN UN COUP D'ŒIL



10.59°N 14.32°E, Cameroun · Natural Earth

- **Le risque.** 2 500 décès dus à la chaleur prévus dans la région d'ici mars, auxquels s'ajoutent la méningite et le choléra ; aucun décès dû à la chaleur n'a jamais été officiellement compté ici.
- **Pour vous.** D'ici le 30 novembre, gardez à la maison des SRO et du zinc pour chaque enfant de moins de cinq ans, et renouvelez-les d'ici le 15 février.*
- **L'argent.** XAF 97 à 370 millions (165 000 à 630 000 $ US) ; ce sont les transferts monétaires aux ménages les plus pauvres en février qui sont les plus utiles.
- **À ne pas faire.** Au-dessus d'environ 38 °C, ne vous asseyez pas devant un ventilateur, même la peau mouillée : mouillez la peau, ventilateur éteint.*

Pour vous, habitants	9 étapes	p. 2
Que faire	**9** actions	p. 6
Qui fait quoi	matrice RACI	p. 16
Où l'argent est le plus utile	financement	p. 16
À ne pas faire	**4** points	p. 18
Ce qui s'est passé ici	l'historique	p. 20
Comment cette note a été produite	méthodologie	p. 22
Références	sources	p. 24

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

chaleur seule. Aucune part de la ville n'a été calculée. Peu de décès sont enregistrés dans la région et aucun décès dû à la chaleur n'a jamais été officiellement compté ; la prévision ne peut donc pas être confrontée à un décompte local. Après vérification, l'objectif de financement passe de XAF 264,2 millions (450 000 $ US) à XAF 184,9 millions (315 000 $ US), soit une baisse de 30 %. L'Adaptation Inventory du Climate Impact Lab, chargé dans le navigateur, n'a renvoyé aucune entrée aux agents de recherche ; aucun précédent n'a pu y être confirmé.

POUR VOUS, HABITANTS

9 ÉTAPES

Pour une famille de Maroua, cet El Niño se traduit par deux épisodes de chaleur, l'un maintenant et un pire en mars, accompagnés de délestages. La méningite arrive avec la saison sèche et le choléra avec les pluies. Les personnes les plus exposées au risque de décès sont les jeunes enfants qui ont la diarrhée et les personnes âgées seules sous un toit de tôle. Les actions classées plus bas s'adressent à la région et à ses partenaires. Voici celles que vous pouvez mener vous-même.

D'ici le 30 novembre, gardez à la maison des sels de réhydratation orale (SRO) et du zinc pour chaque enfant de moins de cinq ans, et renouvelez-les d'ici le 15 février*

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 1

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
30 novembre 2026 ; renouvellement d'ici le 15 février 2027	faible ; le prix local n'a pas été vérifié : renseignez-vous au centre de santé intégré (CSI) ou en pharmacie	les enfants de moins de cinq ans

Dans une population sahélienne (Nouna, au Burkina Faso), les décès d'enfants de moins de cinq ans augmentaient de 3,7 % pour chaque degré (1 °C) de chaleur supplémentaire. La diarrhée est l'une des principales façons dont la chaleur tue les jeunes enfants. On estime que les SRO donnés tôt évitent la plupart des décès par diarrhée chez les moins de cinq ans ; cette estimation provient d'une revue fondée sur une modélisation, et non d'un essai mené à Maroua. Commencez les SRO dès la première selle liquide, et allez au centre de santé si l'enfant ne peut pas boire, s'il est très somnolent ou si la diarrhée contient du sang.*

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Traitez et couvrez toute l'eau de boisson, et donnez à chaque personne son propre gobelet

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ISSU DE L'ACTION 7

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
dès maintenant, et chaque jour pendant la saison chaude	un bidon avec couvercle et du chlore ou de l'eau de Javel ; prix locaux non vérifiés	tout le ménage, contre le choléra

L'épidémie de choléra de 2010 a tué 602 personnes dans l'Extrême-Nord, et une étude menée dans la région a constaté que les gens partageaient les gobelets aux jarres d'eau installées en bord de route. En janvier 2026, des ménages de Maroua partageaient des points d'eau non protégés avec le bétail pendant que Camwater envoyait des camions-citernes d'urgence. Une eau qui paraît propre peut tout de même transmettre le choléra.

Aux heures les plus chaudes, mouillez votre peau et vos vêtements et reposez-vous à l'ombre ; au-dessus d'environ 38 °C, laissez le ventilateur éteint *

CONFIRMÉ · SELON LE RÔLE

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
dès maintenant et jusqu'en novembre, puis de nouveau à partir de mars 2027	aucun	les personnes âgées, les personnes qui travaillent dehors et toute personne malade

Lors d'un essai en laboratoire de 2024, à 45 °C et 15 % d'humidité, des conditions proches de celles de mars et avril à Maroua, le ventilateur augmentait l'effort du cœur, tandis que mouiller la peau, ventilateur éteint, aidait. Dans la mesure du possible, déplacez vos courses et vos travaux en plein air hors de la plage de 11 h à 16 h. Voir « À ne pas faire » pour l'explication complète. *

Apprenez les signes du coup de chaleur et agissez vite : confusion, effondrement ou convulsions, et peau très chaude *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · SELON LE RÔLE

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
dès maintenant	aucun	tous les membres du ménage

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Mettez la personne à l'ombre, versez de l'eau sur sa peau et emmenez-la au centre de santé le plus proche ou à l'Hôpital régional de Maroua. Au Cameroun, les numéros d'urgence sont le 119 pour l'aide médicale, le 118 pour les sapeurs-pompiers et le 117 pour la police. Ces numéros proviennent des conseils aux voyageurs du gouvernement canadien, et non d'une source camerounaise ; gardez donc aussi le numéro de votre centre de santé.*

Convenez avec un voisin de vous rendre visite mutuellement vers 14 h les jours de forte chaleur

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 3

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
30 novembre 2026	aucun	les personnes âgées qui vivent seules, les bébés dans des pièces sous toit de tôle et les familles déplacées

Les personnes qui meurent de la chaleur se trouvent le plus souvent chez elles et seules, et non dans la rue. À Rome, un programme de contacts réguliers avec les personnes âgées isolées a été associé à moins de la moitié des décès dus à la chaleur attendus. Ces données viennent d'Italie, et non du Cameroun, mais cette étape ne coûte rien.

De décembre à juin, emmenez le jour même au centre de santé toute personne qui a de la fièvre et la nuque raide*

CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 2

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
décembre 2026 – juin 2027	le transport ; renseignez-vous sur la gratuité du traitement en période d'épidémie	les enfants et les jeunes adultes

L'épidémie de méningite de 1992 dans le nord du Cameroun a fait 968 morts. Le vaccin administré depuis 2011 a arrêté le sérogroupe A, mais le sérogroupe W circule toujours, et ce sont les antibiotiques donnés tôt qui sauvent des vies. Un nourrisson mou ou dont la fontanelle est bombée doit lui aussi être conduit au centre de santé le jour même.*

En prévision des délestages, gardez une radio avec des piles de rechange et un téléphone chargé, et écoutez RFI sur 101,6 FM pour les alertes chaleur

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 5

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
30 novembre 2026	les piles ; prix local non vérifié	l'accès du ménage aux alertes pendant les coupures

Les délestages ont frappé Maroua à partir du 20 janvier 2026, faute d'eau suffisante dans la retenue de Lagdo. RFI émet à Maroua sur 101,6 FM en français, en haoussa et en fulfulde. L'Observatoire national sur les changements climatiques (ONACC) a émis des alertes chaleur pour l'Extrême-Nord en 2024 et en 2026.

Si vous jeûnez pendant le Ramadan (prévu vers le 8 février – 9 mars) ou le carême (à partir du 10 février), buvez abondamment entre le coucher et le lever du soleil, et demandez à votre imam ou à votre pasteur quelles dispenses s'appliquent aux malades, aux personnes âgées et aux femmes enceintes

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 8

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
février–mars 2027	aucun	les personnes âgées et toute personne atteinte d'une maladie chronique

Le Ramadan tombe en plein dans le pic prévu en mars. En février 2026, l'ONACC a mis en garde contre la déshydratation et le coup de chaleur chez les personnes qui jeûnaient à Maroua, avec des maximales de 40 à 46 °C. Lors de la vague de chaleur de 2015 à Karachi, le jeûne en lui-même n'est pas apparu comme un facteur de risque significatif ; il s'agit donc d'une protection de bon sens, et non d'une cause de décès prouvée.

Si vous avez de l'argent disponible, achetez d'ici le 15 décembre, pendant que les prix sont bas, le sorgho dont vous aurez besoin de mars à mai, et conservez-le dans des sacs hermétiques

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 9

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
15 décembre 2026	sacs hermétiques à environ XAF 1 200 à 2 350 (2 à 4 $ US) pièce ; aucun vendeur vérifié dans le	les réserves alimentaires du ménage pendant la soudure

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Nord : renseignez-vous auprès des revendeurs d'intrants agricoles

À la récolte, le sorgho rouge de Maroua était 38 % en dessous de sa moyenne quinquennale, et FEWS NET prévoit une hausse d'environ 40 % d'ici mai 2027. N'achetez à l'avance que si l'argent n'est pas nécessaire pour quelque chose de plus urgent, et conservez les céréales stockées en sécurité.

Ce qu'il faut demander aux responsables

- Demander au chef de votre district de santé où se trouvera le point de réhydratation le plus proche dans votre quartier, et s'il est approvisionné (action 1).
- Demander à votre chef de quartier si la liste des personnes isolées du quartier existe déjà, et qui passe les voir (action 3).
- Demander aux services du Gouverneur si l'Hôpital régional et les pompes de Camwater figurent sur une liste écrite de lignes protégées des délestages (action 6).
- Demander à votre commune quand commencent dans votre quartier les tournées programmées des camions-citernes de Camwater (action 7).

CE QUE CETTE LOCALITÉ DEVRAIT FAIRE — PAR ORDRE DE PRIORITÉ

Classées selon le nombre de vies qu'elles devraient sauver par unité d'effort avant le pic. Les éclairages experts qui soutiennent chaque action

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

sont indiqués ; une action à laquelle plusieurs éclairages sont parvenus indépendamment est le pari le plus sûr.

1. Mettre la réhydratation là où vivent les gens : une dizaine de points communautaires de SRO et de zinc dans les communes de Maroua Ier, IIe et IIIe d'ici le 30 novembre, réapprovisionnés d'ici le 15 février

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · GESTIONNAIRE D'URGENCE · SANTÉ PUBLIQUE · HISTORIEN · SCEPTIQUE · PHILANTHROPE

ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Délégation régionale de la Santé publique (DRSP) de l'Extrême-Nord et chefs des districts de santé de Maroua	30 novembre 2026 ; réapprovisionnement d'ici le 15 février 2027	environ XAF 3 millions (5 100 $ US), estimation sans source ; payeur : la riposte au choléra déjà financée par le CERF	les décès par choléra et par déshydratation à domicile et sur le chemin des soins

Chaque point dispose de SRO, de zinc et de Ringer lactate, ainsi que d'une moto pour les références. Une étude de 97 cas mortels évocateurs du choléra dans l'Extrême-Nord (2009–2011) a montré que 39 % des personnes étaient décédées dans la communauté et 5 % pendant le transport. Une étude nationale portant sur 2010 a montré que les personnes décédées vivaient plus loin des soins et utilisaient rarement les SRO à domicile. Le choléra est actif dans l'Extrême-Nord en 2026 : 585 cas et 19 décès au cours des trois premières semaines de juillet. Les points servent aussi lors des pics de chaleur, car c'est par la déshydratation que la chaleur tue les jeunes enfants.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : les données sur le choléra proviennent de l'Extrême-Nord lui-même. Le lien avec la chaleur repose sur une étude menée à Nouna, au Burkina Faso (décès des moins de cinq ans +3,7 % par degré), un contexte sahélien comparable. L'effet des SRO est une estimation modélisée. Ici, le choléra culmine avec les pluies ; il s'agit donc d'une mesure contre le choléra qui aide aussi en période de chaleur, et non principalement d'une mesure contre la chaleur de mars. Le CERF a accordé XAF 587 millions (1 million de $ US) à la riposte au choléra dans l'Extrême-Nord en août 2026 ; cette action devrait être payée sur ces fonds, et non avec de l'argent nouveau.

2. Se préparer à la méningite avant la saison : constituer des stocks de ceftriaxone et de tests rapides dans chaque formation sanitaire d'ici le 15 décembre, et tenir prête la demande de vaccins d'urgence

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | HISTORIEN · ÉCONOMISTE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
DRSP de l'Extrême-Nord, avec l'OMS	15 décembre 2026, avant la saison de décembre à juin	non chiffré ; le vaccin d'épidémie est financé par Gavi par l'intermédiaire du stock de l'ICG	les décès par méningite chez les enfants et les jeunes adultes

L'épidémie de 1992 dans le nord du Cameroun a causé 8 046 cas et 968 décès. La campagne MenAfriVac de 2011 a éliminé le sérogroupe A, et aucun A n'a été isolé depuis 2014. Depuis 2013, le seul sérogroupe isolé est le W, que ce vaccin ne couvre pas. Une revue de 2025 indique que le vaccin contre la méningite A n'était pas encore entré dans le calendrier vaccinal de routine du Cameroun, la vaccination dans l'Extrême-Nord devant s'achever en 2026. La DRSP devrait donc vérifier quels enfants nés depuis 2012 sont protégés, constituer des stocks de traitement et préparer une demande au Groupe international de coordination (ICG) pour le vaccin pentavalent (Men5CV) si un district franchit le seuil épidémique.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : il s'agit de l'historique propre à la région. La « couverture de 101 % » de la campagne de 2011 était administrative et surestimée ; la protection réelle des plus jeunes enfants est donc inconnue.

3. Repérer les ménages invisibles : d'ici le 30 novembre, les volontaires de la Croix-Rouge et chaque chef de quartier dressent la liste des personnes isolées et attribuent à chacune un voisin qui passe la voir vers 14 h les jours de forte chaleur

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | INTERVENANT DE TERRAIN · GESTIONNAIRE D'URGENCE · SANTÉ PUBLIQUE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Croix-Rouge camerounaise, comité départemental du Diamaré, avec les chefs de quartier	30 novembre 2026 ; mise à jour d'ici le 15 février 2027	quasi nul (temps des volontaires)	les décès à domicile chez les personnes que personne ne vient voir

La liste comprend les personnes âgées qui vivent seules, les personnes déplacées hébergées par des familles d'accueil, ainsi que les nourrissons et les enfants atteints de malnutrition sévère dans des pièces sous toit de tôle. Chaque équipe compte au moins une femme, car ce sont les femmes qui s'occupent des malades et certaines ne parleront pas à des volontaires masculins. L'Extrême-Nord compte 510 855 personnes déplacées internes (OIM, juillet 2025). La Croix-Rouge dispose à Maroua d'une délégation du Diamaré et d'un entrepôt.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : les seules données sur les résultats viennent de Rome, où un programme de contacts réguliers avec les personnes isolées de plus de 75 ans a été associé à une mortalité due à la chaleur inférieure à la moitié du taux attendu (IRR 0,44). Il s'agit d'une étude observationnelle menée dans un pays à revenu élevé. Aucun modèle éprouvé n'existe dans un pays à faible revenu ; il faut donc considérer cette action comme une pratique transposée.

4. Verser de l'argent aux ménages les plus pauvres en février, avant le pic de mars, par l'intermédiaire de l'appel d'urgence de la Croix-Rouge sur l'insécurité alimentaire

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ÉCONOMISTE · PHILANTHROPE · ALIMENTATION | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Croix-Rouge camerounaise, avec la FICR	contrats en janvier ; versement en février 2027	XAF 85,5 millions (145 600 $ US) pour 1 500 ménages, plus environ 12 % de frais de distribution	des ménages qui réduisent la nourriture, l'eau et les soins pendant le pic de chaleur et la soudure

L'appel d'urgence MDRCM042 de la FICR (insécurité alimentaire au Cameroun) court jusqu'au 30 juin 2027 et n'est financé qu'à 19 %. À Yagoua, en juin 2026, il a versé XAF 57 000 par ménage à 900 ménages. Un complément réservé au Diamaré atteint 1 500 des ménages les plus pauvres et des ménages déplacés, au même montant. La liste devrait être croisée avec les listes de transferts d'urgence du projet de filets sociaux financé par la Banque mondiale (PFS-AIE), afin qu'aucun ménage ne soit payé deux fois.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : l'action passe par des systèmes de paiement que la Croix-Rouge a déjà utilisés dans la région en 2026. Ici, l'argent l'emporte sur l'aide alimentaire, car les marchés de Maroua fonctionnent et les céréales sont bon marché. L'économiste a proposé de débloquer l'argent lorsque la station de Maroua-Salak atteint 44 °C pendant trois jours. Ce n'est qu'une proposition : rien de tel n'existe au Cameroun, et aucun relevé officiel n'indique à quelle fréquence Maroua atteint cette température.

5. Expérimenter une alerte chaleur qui change ce que fait le système de santé : l'alerte de l'ONACC déclenche un protocole chaleur dans les formations sanitaires et des coins de rafraîchissement d'ici le 15 février

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SANTÉ PUBLIQUE · HISTORIEN · GESTIONNAIRE D'URGENCE · PHILANTHROPE · INTERVENANT DE TERRAIN

ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
DRSP de l'Extrême-Nord, à partir des bulletins de l'ONACC	pathologies liées à la chaleur dans le rapport hebdomadaire de surveillance d'ici le 1er décembre 2026 ; coins de rafraîchissement d'ici le 15 février 2027	environ XAF 500 000 (850 $ US) par coin de rafraîchissement, estimation ; projet pilote de XAF 44 millions (75 000 $ US), voir le financement	les coups de chaleur non traités, et un bilan des décès invisible

Lorsque l'ONACC émet une alerte chaleur, les formations sanitaires passent à un protocole chaleur : triage des pathologies liées à la chaleur, contrôles supplémentaires des enfants atteints de malnutrition sévère, et messages sur le service en fulfulde de RFI. L'Hôpital régional et chaque hôpital de district disposent d'un coin de rafraîchissement avec de l'ombre, de l'eau pour mouiller la peau, de la glace quand l'électricité le permet, et un protocole écrit. Les pathologies et les décès liés à la chaleur sont ajoutés au rapport hebdomadaire de surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR). L'ONACC avait déjà prévu 35 à 45 °C pour le Nord en avril 2024, et le ministère de la Santé publique a diffusé des conseils contre la chaleur en mai de la même année, mais il n'existe ni plan chaleur-santé ni système d'alerte.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : faible. La référence habituelle, le plan d'action contre la chaleur d'Ahmedabad, a estimé à 1 190 le nombre de décès évités chaque année, mais ses propres auteurs indiquent qu'aucune des différences n'était statistiquement significative, et Ahmedabad est une ville de plus de 5 millions d'habitants dotée d'un système municipal. Il faut donc traiter cette action comme un projet pilote peu coûteux, sans promettre d'effet sur la mortalité. Compter les décès dus à la chaleur a une valeur en soi : sans ce décompte, personne ne saura si l'une de ces actions a fonctionné.

6. Maintenir l'alimentation électrique de l'hôpital et des pompes à eau : une liste écrite de lignes protégées d'ici le 30 novembre, et un stock de gazole calé sur la consommation réelle de l'hôpital

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | GESTIONNAIRE D'URGENCE · SCEPTIQUE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Services du Gouverneur de l'Extrême-Nord, avec SOCADEL (ex-Eneo) et Camwater	30 novembre 2026	la liste ne coûte rien ; le gazole pour 30 jours à raison de 10 heures de coupure par jour coûte environ XAF 6 à 7,5 millions (10 200 à 12 800 $ US), estimation	la défaillance de l'hôpital et de l'approvisionnement en eau pendant le pic

Les délestages ont commencé le 20 janvier 2026 à Maroua et dans six autres villes du Nord, faute d'un remplissage suffisant de la retenue de Lagdo. Le secours est assuré par 72 MW de centrales thermiques, limitées par les moyens disponibles pour acheter le carburant. En 2016–2017, la presse rapportait que « les hôpitaux et les prisons n'échappent pas aux délestages ». Aucune liste de clients prioritaires pour le Nord n'a été publiée. L'entreprise d'électricité a été renationalisée en mai 2026 sous le nom de SOCADEL, et son appel d'offres d'octobre pour environ 10 MW de groupes de secours n'indique aucune date de mise en service.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : il s'agit d'une défaillance locale avec une solution locale. Le chiffre du gazole est une estimation. La première proposition de 3 000 litres ne couvrirait que 3 à 4 heures de coupure par jour ; il faut donc calibrer le stock sur la consommation mesurée du groupe électrogène, au prix réglementé à la pompe de XAF 828 le litre.

7. Livrer l'eau selon un calendrier à partir du 1er février, sans compter sur le protocole d'action précoce contre le choléra pour financer Maroua

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | HISTORIEN · ÉCONOMISTE · INTERVENANT DE TERRAIN · SCEPTIQUE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Camwater, avec les communes de Maroua Ier, IIe et IIIe	1er février 2027	non chiffré ; non financé	le recours à une eau non potable pendant la saison sèche, et le choléra

En janvier 2026, Camwater a envoyé un camion-citerne d'urgence à Maroua, et des ménages partageaient des points d'eau non protégés avec le bétail. Les 3 000 forages promis à Maroua en 2011 n'ont pas été réalisés. Les tournées programmées de camions-citernes et la réparation des points d'eau devraient commencer avant la chaleur de mars, et non après une pénurie. Le protocole d'action précoce de la Croix-Rouge contre le choléra (approuvé en mars 2025, CHF 549 807) se déclenche sur des inondations ou de fortes pluies, couvre des districts situés principalement dans le Littoral, le Sud-Ouest et le Centre, et ne cite pas Maroua. Il ne peut pas se déclencher pour une épidémie de saison sèche ; il faut donc plutôt demander à la Croix-Rouge et au ministère de la Santé publique une couverture de contingence.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : l'action est locale. Le protocole contre les crues fluviales (mars 2026) ne couvre que le Mayo-Danay et le Logone-et-Chari, et non le Diamaré.

8. Convenir d'un message pour le Ramadan et le carême avec les imams et les pasteurs d'ici le 15 janvier

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | INTERVENANT DE TERRAIN | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Imams du Lamidat de Maroua et responsables des Églises	15 janvier 2027	aucun	la déshydratation chez les personnes qui jeûnent pendant la chaleur de mars

Le Ramadan 2027 est attendu d'environ le 8 février au 9 mars, selon l'observation de la lune, et le carême commence le 10 février. Les deux chevauchent le pic prévu en mars. En février 2026, l'ONACC a mis en garde contre la déshydratation et le coup de chaleur chez les personnes qui jeûnaient à Maroua, Kousseri, Mora et Yagoua. Le message : boire abondamment entre le coucher et le lever du soleil, connaître les signes du coup de chaleur, et rappeler les dispenses prévues pour les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.

Transférabilité : lors de la vague de chaleur de 2015 à Karachi, le jeûne n'était pas un facteur de risque significatif ; le faible revenu et le faible niveau d'instruction l'étaient. Présenter le message comme un conseil de protection, et non comme un avertissement selon lequel le jeûne tue.

9. Acheter le sorgho pendant qu'il est bon marché : appels d'offres de l'Office céréalier en novembre–décembre, remise en vente à prix coûtant de mars à mai

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ALIMENTATION | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Office céréalier, avec le MINCOMMERCE	achats d'ici le 31 décembre 2026 ; remise en vente de mars à mai 2027	environ XAF 103 millions (175 400 $ US) pour 1 000 tonnes ; non financé	une flambée des prix pendant la soudure, dont les commerçants peuvent profiter

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la récolte, le sorgho rouge de Maroua était 13 % en dessous de l'an dernier et 38 % en dessous de sa moyenne quinquennale (FEWS NET, octobre 2026). FEWS NET prévoit une hausse d'environ 40 % d'ici mai 2027, avec l'Extrême-Nord en phase 3 de l'IPC à partir de février. Le prix de gros en mai 2026 était d'environ XAF 103 000 la tonne. Des ventes promotionnelles de riz et d'huile par le MINCOMMERCE avant le Ramadan aideraient aussi, par l'intermédiaire de la MIRAP si elle opère à Maroua (non confirmé).

Transférabilité : ici, le signal alimentaire d'El Niño est faible. FEWS NET indique qu'El Niño ne devrait pas provoquer d'anomalies de pluviométrie significatives au Cameroun, et le conflit, le naira et les baisses de l'aide pèsent davantage sur les prix. 1 000 tonnes, c'est peu au regard des besoins de la région, et de gros achats d'ONG ont déjà fait monter les prix dans l'Extrême-Nord ; il faut donc acheter par des appels d'offres étalés dans le temps. Aucune opération de l'Office céréalier en 2026 n'a été trouvée.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

QUI FAIT QUOI

MATRICE RACI

R = Réalise (exécute le travail) · **A** = Approuve (un seul par action ; valide et en répond) · **C** = Consulté (sollicité avant) · **I** = Informé (tenu au courant après). Établie à partir des responsables désignés dans les actions vérifiées. Personne ici n'a été contacté ni n'a accepté de rôle ; chaque ligne est une proposition.

Action	DRSP et districts de santé	Services du Gouverneur	Croix-Rouge (Diamaré)	SOCADEL et Camwater	Communes et chefs de quartier	Imams et pasteurs	Partenaires des Nations unies (OMS, UNICEF, PAM, FICR)	Office céréalier et MINCOMMERCE
1. Points communautaires de SRO	**A/R**	**I**	**R**		**C**	**I**	**C**	
2. Stocks contre la méningite et demande de vaccins	**A/R**	**I**	**C**		**I**	**I**	**R**	
3. Listes des personnes isolées	**C**	**I**	**A/R**		**R**	**C**		
4. Transferts monétaires de février		**C**	**A/R**		**C**		**R**	
5. Projet pilote de protocole chaleur	**A/R**	**I**	**C**	**C**	**I**	**I**	**C**	
6. Lignes électriques protégées	**C**	**A**		**R**	**I**			
7. Livraisons d'eau programmées	**C**	**I**	**C**	**A/R**	**R**		**C**	
8. Message pour le Ramadan et le carême	**C**	**I**			**I**	**A/R**		
9. Achat de sorgho		**C**			**C**		**C**	**A/R**

Ce que montre la matrice : la DRSP approuve trois des neuf actions et est consultée sur quatre autres ; c'est donc la délégation de la santé qui porte ce plan. La Croix-Rouge approuve les deux actions qui atteignent directement les ménages. Les lignes 3, 6 et 8 dépendent d'une décision, et non d'argent.

OÙ L'ARGENT EST LE PLUS UTILE

FINANCEMENT

L'éclairage du philanthrope, rapproché des actions classées et vérifié. Les affectations sont classées selon les vies supplémentaires sauvées par dollar. L'enveloppe est limitée par ce que la localité peut dépenser avant le pic, et non par ses besoins.

PLANCHER	OBJECTIF	PLAFOND	PRINCIPALE INCERTITUDE
XAF 96,9 millions (165 000 $ US)	**XAF 184,9 millions (315 000 $ US)**	**XAF 369,9 millions (630 000 $ US)**	**Personne ne compte ici les décès dus à la chaleur ; l'effet d'aucune affectation ne peut donc être mesuré**

Plancher : les seuls transferts monétaires de février, 1 500 ménages × XAF 57 000 = XAF 85,5 millions (145 600 $ US), plus environ 12 % pour la distribution et le ciblage, arrondi à XAF 96,9 millions (165 000 $ US). Ils passent par un canal qui a effectué des versements dans la région en juin 2026. Objectif : le plancher, plus un projet pilote de protocole chaleur de XAF 44 millions (75 000 $ US : 30 formations sanitaires × 1 500 $ US, plus 20 000 $ US pour la formation et 10 000 $ US pour les alertes), plus XAF 44 millions (75 000 $ US) pour le traitement de la

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

malnutrition sévère (500 enfants × environ XAF 88 000, soit 150 $ US, tout compris), soit XAF 184,9 millions (315 000 $ US). Plafond : des transferts pour 3 000 ménages, XAF 193,8 millions (330 000 $ US) ; le projet pilote à l'échelle complète proposée par le panel, XAF 88,1 millions (150 000 $ US) ; le traitement de la malnutrition, XAF 44 millions (75 000 $ US) ; et XAF 44 millions (75 000 $ US) pour des points d'eau, uniquement si le cluster eau, hygiène et assainissement confirme un manque au-delà des fonds du CERF. Soit XAF 369,9 millions (630 000 $ US). Le panel proposait un objectif de XAF 264,2 millions (450 000 $ US) ; il a baissé de 30 %, car une ligne consacrée à l'eau faisait double emploi avec des fonds du CERF déjà engagés et le coût par formation sanitaire était sans source.

BÉNÉFICIAIRE	UTILISATION	MONTANT	MÉCANISME	FONDEMENT	VERDICT
Croix-Rouge camerounaise, par l'appel MDRCM042 de la FICR	Action 4 : transferts monétaires à 1 500 ménages du Diamaré en février	XAF 96,9 millions (165 000 $ US) ; jusqu'à XAF 193,8 millions (330 000 $ US) pour 3 000 ménages	complément	XAF 57 000 par ménage, Yagoua, juin 2026 ; appel financé à 19 %	Confirmé
DRSP de l'Extrême-Nord	Action 5 : projet pilote de protocole chaleur, coins de rafraîchissement et alertes	XAF 44 millions (75 000 $ US) ; jusqu'à XAF 88,1 millions (150 000 $ US)	subvention directe	XAF 880 700 (1 500 $ US) par formation sanitaire est une estimation ; Maroua 2 compte 11 formations sanitaires et Maroua 3 en compte 10. Aucun effet sur la mortalité n'est promis.	Partiellement confirmé
Chaîne d'approvisionnement de l'UNICEF, pour le traitement de la malnutrition sévère	Action 5 : les enfants les plus exposés à la chaleur	XAF 44 millions (75 000 $ US)	stock prépositionné	Aliment thérapeutique à environ XAF 27 400 (47 $ US) le carton (CHAI) ; environ XAF 88 000 (150 $ US) par enfant traité, tout compris, estimation	Partiellement confirmé

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

BÉNÉFICIAIRE	UTILISATION	MONTANT	MÉCANISME	FONDEMENT	VERDICT
Partenaires eau et assainissement, uniquement si un manque est confirmé	Action 7 : points d'eau dans les quartiers les plus touchés	XAF 44 millions (75 000 $ US), plafond uniquement	subvention directe	Aucun coût unitaire publié ; le CERF finance déjà la riposte au choléra	Partiellement confirmé

Le point de vue d'un bailleur : ici, personne ne finance la lutte contre la chaleur. Le plan humanitaire 2026 était financé à 26 % en août, et les fonds préétablis pour l'Extrême-Nord ne couvrent que le choléra et les crues fluviales. Les décès de novembre sont en grande partie hors de portée d'un argent nouveau ; c'est au pic de mars que les vies les moins chères à sauver peuvent encore l'être, si l'argent est engagé avant janvier. Gavi finance déjà le vaccin contre la méningite : ne pas dépenser pour cela.

À ne pas faire

CONTRE-INDIQUÉ · DES CONSEILS QUI COÛTERAIENT DES VIES ICI

Des conseils qui circulent face à cet aléa et qui coûteraient des vies ici.

Conseiller de s'asseoir devant un ventilateur pendant la saison chaude, même la peau mouillée *

CONTRE-INDIQUÉ CORRIGÉ

Au-dessus d'environ 38 °C pour les plus de 65 ans (37 °C pour les personnes qui prennent certains médicaments, 39 °C pour les jeunes adultes), un ventilateur souffle de l'air chaud sur le corps et ajoute de la chaleur (Morris, Jay et collègues, *Lancet Planetary Health* 2021). En mars et en avril, les après-midi de Maroua atteignent environ 40 °C avec 11 à 26 % d'humidité, soit dans cette zone. Lors d'un essai de 2024 à 45 °C et 15 % d'humidité, le ventilateur augmentait l'effort du cœur, et un essai de 2025 a montré que mouiller la peau ne compensait pas l'effet néfaste du ventilateur. Le projet de conseil du panel lui-même, ainsi qu'une proposition de financer des ventilateurs solaires, se seraient trompés sur ce point.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : mouiller la peau et les vêtements, ventilateur éteint, se reposer à l'ombre et boire. N'utiliser un ventilateur que lorsque l'air est en dessous d'environ 38 °C, la nuit par exemple.

Se contenter de dire « buvez plus d'eau »

CONTRE-INDIQUÉ CONFIRMÉ

Pendant la saison sèche, l'eau à laquelle les gens ont accès est souvent partagée avec le bétail ou vendue dans des jarres ouvertes avec des gobelets communs. L'épidémie de choléra de 2010 a tué 602 personnes dans l'Extrême-Nord, et le choléra est de nouveau actif dans la région en 2026.

À la place : « buvez de l'eau traitée et couverte, dans votre propre gobelet », avec des SRO à domicile et aux points communautaires.*

Compter sur les SMS ou les affiches pour les alertes

CONTRE-INDIQUÉ CORRIGÉ

Seules 17 % environ des femmes rurales de l'Extrême-Nord savaient lire (chiffre ministériel de 2012, le plus récent trouvé pour la région). Ce sont les femmes qui portent l'eau et soignent les malades ; une alerte écrite manque donc les personnes qui doivent agir.

À la place : la radio (le service en fulfulde et en français de RFI sur 101,6 FM), les imams et les pasteurs, les chefs de quartier, les agents de santé communautaires et de courts messages vocaux en fulfulde.

Installer des centres de rafraîchissement qui attirent la foule au grand marché à la mi-journée

CONTRE-INDIQUÉ CORRIGÉ

Le 22 juillet 2015, vers 14 h 30, deux kamikazes ont frappé l'entrée du grand marché et le quartier Barmaré, tuant 13 personnes, kamikazes compris. Aucun attentat n'a été recensé dans la ville même de Maroua en 2025–2026, mais les attaques se poursuivent dans le Mayo-Sava. Vérifier les consignes de sécurité en vigueur avant de prévoir tout rassemblement public. Un centre qu'il faut rejoindre en traversant la ville dans la chaleur de midi manque aussi les personnes les moins capables de se déplacer.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : de l'ombre et de l'eau là où les gens vont déjà : centres de santé, mosquées, églises et stationnements de mototaxis.

CE QUI S'EST DÉJÀ PASSÉ ICI — L'HISTORIQUE

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
1992	Épidémie de méningite, nord du Cameroun, janvier–mai, pendant l'El Niño de 1991–1992	968 décès, 8 046 cas (ministère de la Santé publique, données non publiées, citées en 2013)	Vaccination de masse par MenAfriVac seulement en décembre 2011 ; le sérogroupe A a ensuite disparu
1998	Choléra, Extrême-Nord, juin–octobre (saison des pluies)	107 décès, 633 cas (létalité de 17 %) ; 12 décès à Maroua en zone urbaine	La létalité a baissé lors des épidémies suivantes, grâce à la décentralisation du traitement
2010	Choléra, Extrême-Nord, à partir du 6 mai, la pire épidémie de la région en plus de 20 ans	602 décès, 9 421 cas (88 % des cas du Cameroun)	Centres de traitement communautaires temporaires ; approvisionnement en eau toujours pas réglé
2012	Inondations après la rupture de la digue de Maga	37 816 personnes déplacées dans l'Extrême-Nord ; bilan régional des décès non établi	Le protocole d'action précoce contre les inondations de 2026 couvre le Mayo-Danay et le Logone-et-Chari, et non le Diamaré
2015	Double attentat-suicide, grand marché et Barmaré, 22 juillet	13 morts, kamikazes compris ; 32 blessés	La sécurité des foules conditionne depuis tout rassemblement public
2024	Chaleur de mars–avril, la plus forte depuis 1981 dans l'Extrême-Nord (PAM), pendant l'El Niño de 2023–2024	Aucun décompte officiel ; les informations faisant état de « nombreux » décès et de 50 à 60 inhumations par jour sont sans source	Alertes de l'ONACC et conseils du ministère ; aucun plan chaleur, et décès dus à la chaleur toujours pas comptés
2024	Inondations, août–octobre, surtout dans le Mayo-Danay et le Logone-et-Chari	30 décès (OCHA, septembre) ; 365 060 personnes touchées	CERF : XAF 2,35 milliards (4 millions de $ US) après l'événement

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
2026	Délestages à partir du 20 janvier (retenue de Lagdo basse) ; choléra à partir de juillet	Choléra : 19 décès au 22 juillet, 31 au 12 août, dans la région	Eneo renationalisée sous le nom de SOCADEL ; CERF : XAF 587 millions (1 million de $ US) pour le choléra

La récurrence que personne n'a relevée : l'historien du panel avançait que les pires années de Maroua surviennent pendant la saison sèche qui suit immédiatement un hiver El Niño. Confrontée à l'indice de la NOAA, cette hypothèse ne tient pas. Les épidémies de choléra de 1998 et de 2010 sont arrivées avec les pluies, au moment où s'installait La Niña, et 2010 est l'année la plus meurtrière de cette liste. Ce que les années El Niño apportent ici, c'est la chaleur et la méningite de la saison sèche pendant l'épisode lui-même, comme en 1992 et en 2024. Cet hiver et le mois de mars correspondent exactement à cette fenêtre. La promesse faite à Maroua en 2011, 3 000 forages, n'a pas été tenue, et chaque saison sèche en paie le prix.

LÀ OÙ LES EXPERTS DIVERGENT

NON RÉSOLU

- **Les ventilateurs aident** ou **les ventilateurs nuisent ici**. Le philanthrope et le gestionnaire d'urgence proposaient des ventilateurs, y compris solaires, dans les coins de rafraîchissement. Le sceptique et le vérificateur ont constaté qu'au-dessus d'environ 38 °C, par air sec, les ventilateurs ajoutent de la chaleur, même sur une peau mouillée. Des mesures de température intérieure dans les logements et les formations sanitaires de Maroua pendant la saison chaude permettraient de savoir quand un ventilateur aide.
- **Acheter des céréales maintenant** ou **verser de l'argent plus tard**. L'éclairage alimentation veut que l'Office céréalier achète 1 000 tonnes de sorgho bon marché. Le vérificateur a constaté que les marchés fonctionnent, que l'argent est le meilleur outil et que de gros achats ont déjà fait monter les prix. Des données mensuelles de prix de la FAO pour Maroua montreraient si une flambée des prix se prépare réellement.
- **Débloquer l'argent sur un déclencheur de température** ou **aucun relevé sur lequel le fonder**. L'économiste proposait de verser l'argent lorsque Maroua-Salak atteint 44 °C pendant trois jours. Aucun relevé officiel de la station n'indique à quelle fréquence cela se produit ; le risque de base est donc inconnu. Un historique de la station fourni par la Direction de la météorologie nationale permettrait de trancher.
- **2 500 décès prévus** ou **aucun décompte local**. L'enregistrement des décès est faible dans l'Extrême-Nord (une source de l'UE, non vérifiée de façon indépendante, situe l'enregistrement à l'état civil à 38 %), et aucun décès dû à la chaleur n'a été officiellement compté. L'éclairage santé publique souligne que la prévision ne peut pas être vérifiée ici tant que les décès dus à la chaleur ne sont pas enregistrés ; c'est pourquoi l'action 5 les ajoute à la surveillance.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

CE QUE PERSONNE N'A TRAITÉ — ANGLE MORT

Aucun éclairage n'a étudié les personnes en institution : la prison, les élèves internes des écoles coraniques et les patients des services hospitaliers sans rafraîchissement. Chacun de ces groupes est fermé, et la chaleur et le manque d'eau s'y concentrent. Aucun éclairage n'a interrogé qui que ce soit à Maroua, et aucune donnée quartier par quartier sur le logement, l'accès à l'eau ou les familles déplacées n'a été trouvée ; les actions citent donc les communes de la ville plutôt que des quartiers précis.

COMMENT LIRE CETTE NOTE — MÉTHODE

Le panel a été constitué par l'auteur. Huit éclairages d'experts simulés ont servi à formuler ces recommandations. Lorsqu'ils concordent, il s'agit d'une hypothèse solide, et non d'un consensus de la discipline. Chaque recommandation a ensuite été vérifiée de façon indépendante quant aux preuves, à la transférabilité à cette localité et à la faisabilité avant le pic ; les étiquettes de verdict en rendent compte.

Les chiffres de mortalité sont publiés à l'échelle de la région, ici l'ensemble de la région de l'Extrême-Nord, qui compte plusieurs millions d'habitants. Ce ne sont pas des chiffres propres à la ville. La projection El Niño ne couvre que *la chaleur* ; la méningite, le choléra, les inondations et l'insécurité alimentaire s'y ajoutent et sont traités ici à partir de l'historique plutôt que d'un chiffre publié.

COMMENT CETTE NOTE A ÉTÉ PRODUITE — MÉTHODOLOGIE

- **Périmètre.** Cette note a été produite à l'initiative d'Angus Shaw, et non à la suite d'une demande, comme première note pour le Cameroun, le pays suivant de la liste du tracker de la chaleur qui n'en avait pas encore. L'Extrême-Nord est la région la plus touchée du Cameroun selon le tracker (3 000 des 7 300 décès), et Maroua en est le chef-lieu. La localité retenue est la ville de Maroua (communes de Maroua Ier, IIe et IIIe, département du Diamaré), qui compte environ 300 000 habitants dans la ville et environ 527 000 dans l'agglomération (ONU, 2025). Les chiffres de mortalité n'existent qu'à l'échelle régionale ; les données propres à la ville servent à l'exposition aux aléas et à la conception des actions, et non au décompte des décès. Les actions ne sont pas encore propres à chaque quartier.
- **Exposition.** Données du El Niño Heat Mortality Tracker du Climate Impact Lab, fichier `v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv` (version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs) : région de l'Extrême-Nord (GADM CMR.4_1), 490 décès supplémentaires dus à la chaleur de juin à septembre 2026, 2 500 prévus d'octobre 2026 à mars 2027 (octobre 590, novembre 510, décembre 120, janvier 140, février 200, mars 910), soit 3 000 au total ; Cameroun, 7 300 ; monde, 857 400. Cette mise à jour remplace le rapport de septembre *451,000 at Risk*. Méthode : prévisions saisonnières ECMWF SEAS5 appliquées aux relations température–mortalité par rapport à une

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

référence 1996–2025. Les chiffres ne comptent que la chaleur ; nous l'avons déduit des données, car les pays froids affichent exactement zéro chaque mois d'hiver. Ils ne sont jamais ajoutés aux projections à long terme de l'Impact Map.

- **Panel d'experts.** Huit éclairages d'experts simulés (gestionnaire d'urgence, spécialiste de santé publique, intervenant de terrain, sceptique, économiste, historien, philanthrope et analyste de la chaîne d'approvisionnement alimentaire) ont chacun étudié cette localité de façon indépendante et en parallèle, à partir de sources en ligne, selon un cahier des charges fixe.
- **Rapprochement.** Les actions en double ont été fusionnées et les éclairages qui les soutiennent consignés. La convergence a été testée au regard d'un biais commun (les preuves à l'appui d'une action partagée provenaient-elles d'un contexte semblable à celui-ci ?) avant d'être retenue en faveur d'une action. Les contradictions ont été conservées, et non tranchées en écartant l'un des avis. Les actions ont été classées selon le nombre de vies qu'elles devraient sauver par unité d'effort avant le pic ; chacune s'est vu attribuer un payeur désigné et un déclencheur, ou a été marquée non financée, et les affectations de financement ont été rapprochées de la liste classée.
- **Vérification.** Six agents vérificateurs ont examiné chaque recommandation selon trois critères : les preuves (la source primaire et l'ampleur de l'effet), la transférabilité (ces preuves proviennent-elles d'un contexte comparable ?) et la faisabilité (peut-on la mettre en œuvre ici avant le pic ?). Les actions financières ont en outre été vérifiées quant à leur disponibilité au Cameroun, à l'existence d'un payeur désigné et d'un déclencheur, et à leur éventuelle existence préalable. Les actions alimentaires ont été vérifiées quant aux séries de prix publiées, au calendrier du pic des prix, à la capacité de distribution et au choix entre argent et nature. L'enveloppe de financement a été vérifiée quant à la réalité des bénéficiaires, aux coûts unitaires publiés et aux doublons, puis recalculée. Un vérificateur distinct a confronté chaque événement de l'historique à sa source et à l'indice El Niño de la NOAA.
- **Qui fait quoi.** La matrice RACI est établie à partir des responsables désignés dans les actions vérifiées, avec une seule partie qui approuve par action. Il s'agit d'une proposition : aucune organisation qui y figure n'a été contactée ni n'a accepté de rôle.
- **Verdicts.** *Confirmé* : preuves, transférabilité et faisabilité sont toutes établies. *Partiellement confirmé* : établi après les corrections indiquées. *Non vérifié* : n'a pas pu être rattaché à une source primaire. *Contre-indiqué* : serait nuisible ou gaspillerait la fenêtre d'action ici.
- **Adaptation Inventory.** Non consultable : l'inventaire charge ses entrées dans le navigateur et n'en a renvoyé aucune aux agents de recherche. Aucune action n'est étiquetée avec un précédent qui en serait issu.
- **Montants.** Les coûts sont exprimés en francs CFA d'Afrique centrale (XAF), avec l'équivalent en dollars américains ($ US) entre parenthèses, au taux de XAF 587,14 = 1 $ US. Ce taux découle de la parité fixe de XAF 655,957 = 1 € et du taux de référence de la BCE de 1 € = 1,1172 $ US (30 octobre 2026). Les montants publiés en francs suisses (protocoles de la Croix-Rouge) sont laissés en francs suisses.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Lecteur.** Aucun rôle n'ayant été indiqué, la rubrique « Pour vous » s'adresse à un habitant. Ses étapes sont tirées des actions vérifiées et de ce que le panel a appris sur les ménages d'ici ; toute étape qui ne découle pas d'une action classée a été vérifiée selon les trois mêmes critères. Le reste du rapport s'adresse à la région et à ses partenaires.
- **Formulations de santé.** Les passages où une erreur de formulation pourrait nuire à quelqu'un (fraîcheur et ventilateurs, médicaments et doses, traitement de l'eau et SRO, signes de danger, réserves d'urgence et moment où demander de l'aide) sont signalés par « * Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion ». Ils ont été vérifiés à partir de sources publiées, et non par un professionnel de santé. Ce sont des suggestions, pas des avis médicaux : toute personne qui les relaie doit d'abord les confirmer auprès d'un médecin, d'un pharmacien, d'un infirmier ou d'un agent de santé communautaire. Ce marquage a été ajouté le 2 novembre 2026.
- **Règles.** Aucun coût n'est obtenu en divisant un total publié, et aucun chiffre local n'est inventé ; lorsque les données sont rares, le rapport le signale et donne le chiffre de l'échelon géographique supérieur. Les estimations sont signalées comme telles. Chaque source est répertoriée ci-dessous avec son statut de vérification.
- **Limites.** Le panel et les vérificateurs sont des agents de recherche d'IA travaillant à partir de sources disponibles en ligne, et non des experts humains, et personne n'a été interrogé à Maroua. Les températures de la chaleur de 2024 (moyenne régionale de 34,9 °C, 45 à 46 °C à l'ombre) n'ont pas pu être consultées à la source. Il n'existe aucun décompte officiel des décès dus à la chaleur. Les fichiers de l'Enquête démographique et de santé (EDS) ont renvoyé des erreurs ; le chiffre de l'alphabétisation des femmes date donc de 2012. La situation sécuritaire actuelle dans la ville de Maroua n'a pas été confirmée par une source officielle.
- **Langue.** Les passages marqués « suggested formulation » sont des consignes de sécurité traduites qu'aucun agent de santé de langue maternelle française n'a encore vérifiées.

Références · Climate Impact Lab, données du El Niño Heat Mortality Tracker v261026 (téléchargées le 30 octobre 2026) ; tracker · confirmé
Décès par choléra selon le lieu, Extrême-Nord 2009–2011, AJTMH 2016 · confirmé
Cartwright et al., Epidemiol Infect 2013 · confirmé
Djomassi et al., surveillance nationale du choléra en 2010, J Infect Dis 2013 · confirmé
OMS, choléra au Cameroun, 15 octobre 1998 · confirmé
UNICEF Cameroun, Flash Update No. 2 (Cholera Outbreak), juillet 2026 · confirmé
Munos, Fischer Walker, Black, SRO et mortalité par diarrhée, IJE 2010 · confirmé (modélisé)
Diboulo et al., chaleur et mortalité à Nouna, Global Health Action 2012 · confirmé
Méningite en 1992 et MenAfriVac, Pathog Glob Health 2013 · confirmé ; sérogroupes après 2013, PMC8490062 · confirmé ; introduction dans la vaccination de routine, PAMJ 2025 · confirmé ; Gavi, soutien aux vaccins méningococciques · confirmé
Hess et al., plan d'action contre la chaleur d'Ahmedabad, 2018 · confirmé (non significatif)

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Prévision de chaleur de l'ONACC, Cameroon Tribune, avril 2024 · confirmé ; alerte de l'ONACC sur le jeûne, Journal du Cameroun, février 2026 · confirmé ; conseils du ministère de la Santé publique contre la chaleur, mai 2024 · confirmé

Programme romain pour les personnes isolées et mortalité due à la chaleur, PMC5923757 · confirmé (observationnel)

OCHA, Cameroon: Humanitarian Dashboard, 31 décembre 2025 · confirmé ; la Croix-Rouge à Maroua, Cameroon Tribune · confirmé

FICR, appel MDRCM042 · confirmé ; transferts monétaires à Yagoua, Cameroon Tribune, juin 2026 · confirmé ; Banque mondiale, financement additionnel du PFS-AIE · confirmé

Protocole d'action précoce de la FICR contre le choléra, Anticipation Hub · confirmé ; protocole contre les crues fluviales, MDRCM044 · confirmé

CERF, allocation inondations 2024 · confirmé ; allocation choléra 2026, article · confirmé ; financement du plan humanitaire, Cameroon Tribune, août 2026 · confirmé

Délestages de 2026, Business in Cameroon · confirmé ; renationalisation, Africanews · confirmé ; coupures de 2016–2017, camer.be · confirmé ; prix du gazole, Cameroun24 · confirmé

L'eau et la promesse de forages de 2011, AllAfrica, janvier 2026 · confirmé

Ventilateurs par forte chaleur : Morris et al., Lancet Planet Health 2021 · confirmé ; NEJM 2024 · confirmé

Dates du Ramadan 2027, Gulf News · confirmé (projection) ; le jeûne à Karachi en 2015, Prehosp Disaster Med · confirmé

FEWS NET Cameroun, perspectives d'octobre 2026 et perspectives de juin 2026 · confirmé ; prix du sorgho, FAO FPMA via un agrégateur · confirmé ; Office céréalier, Ecomatin · confirmé ; achats des ONG et prix, Business in Cameroon · confirmé ; déficit de financement du PAM, PAM · confirmé ; sacs hermétiques, TechXLab · confirmé ; prix de l'ATPE, CHAI · confirmé

Attentats de 2015, Présidence de la République du Cameroun · confirmé ; inondations de 2012, ReliefWeb · confirmé ; inondations de 2024, Journal du Cameroun citant OCHA · confirmé ; chaleur de 2024, fiche du PAM · source non ouverte (403)

Alphabétisation, MINPROFF 2012 via Coordination SUD · confirmé ; RFI à Maroua, RFI 2026 · confirmé ; numéros d'urgence, gouvernement du Canada · confirmé (source secondaire) ; signes du coup de chaleur, OMS · consulté

Données d'exposition · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk (remplacé) · Impact Map · Adaptation Inventory

Généré le 30 octobre 2026 pour Maroua, Extrême-Nord. El Niño Ready est une initiative bénévole, sans lien avec la Climate Week NYC, The Climate Group ni l'Université Columbia.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion